Manejo perioperatorio de antiagregantes y anticoagulantes

Cada suspensión es una balanza: el riesgo de sangrar frente al riesgo de trombosar

El doble riesgo · Antiagregantes · Anticoagulantes (AVK y ACOD) · El mito del puente · Reanudación

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al. *Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation (BRIDGE).* N Engl J Med 2015;373(9):823–833. doi:10.1056/NEJMoa1501035 · PMID 26095867.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el manejo perioperatorio de antitrombóticos equilibra dos riesgos opuestos —trombosis si se suspenden y hemorragia si se mantienen—. La decisión depende del fármaco, del riesgo trombótico del paciente y del riesgo hemorrágico del procedimiento. El ensayo BRIDGE desmontó el puente sistemático con heparina en fibrilación auricular.

Cada vez más pacientes quirúrgicos toman antiagregantes o anticoagulantes. Decidir si suspenderlos, cuándo y si hace falta «puente» es una de las consultas perioperatorias más frecuentes —y una balanza entre **sangrar** y **trombosar**—.

Este documento, con ancla **GUÍA**, ofrece el marco de decisión por familias de fármacos, integra la evidencia clave (BRIDGE) y subraya un principio: la conducta se **individualiza** según el riesgo trombótico del paciente y el hemorrágico del procedimiento, siempre conforme al protocolo local.

Índice

1. El doble riesgo: trombosis frente a sangrado
2. Antiagregantes
3. Anticoagulantes: AVK y ACOD
4. El mito del puente: la lección de BRIDGE
5. Reanudación postoperatoria
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. El doble riesgo: trombosis frente a sangrado

Toda decisión sobre antitrombóticos perioperatorios es un **balance**: suspender reduce el sangrado pero expone a **trombosis** (ictus, síndrome coronario, tromboembolismo); mantener protege de la trombosis pero aumenta la **hemorragia**. La conducta correcta cruza tres ejes: el **fármaco** (y su vida media), el **riesgo trombótico** del paciente (motivo de la terapia) y el **riesgo hemorrágico** del procedimiento [2].

PUNTOS CLAVE

- Decisión individualizada: **fármaco × riesgo trombótico × riesgo hemorrágico** [2].
- Muchos procedimientos de bajo riesgo hemorrágico **no exigen suspender** la terapia.
- El **puente** sistemático con heparina suele añadir sangrado sin reducir la trombosis [1].

2. Antiagregantes

En la antiagregación, la **aspirina** en prevención secundaria a menudo puede **mantenerse** en cirugía de riesgo hemorrágico bajo-moderado, mientras que los inhibidores de $P2Y_{12}$ (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) suelen **suspenderse** unos días antes de cirugía mayor por su mayor efecto hemorrágico. El caso crítico es el paciente con **stent coronario reciente** bajo doble antiagregación: posponer la cirugía electiva hasta superar el periodo de riesgo de trombosis del stent y, si es inaplazable, decidir en equipo (cardiología) [2].

3. Anticoagulantes: AVK y ACOD

Los **antagonistas de la vitamina K** (warfarina, acenocumarol) requieren suspensión con varios días de antelación y control del INR; su efecto se revierte, si urge, con **concentrado de complejo protrombínico** y vitamina K (PBM-18). Los **anticoagulantes orales de acción directa (ACOD)** tienen vida media corta y manejo más predecible: se suspenden un número de días según el fármaco, la función renal y el riesgo hemorrágico del procedimiento, habitualmente **sin necesidad de puente** [2]. Existen agentes de reversión específicos para situaciones de hemorragia grave (PBM-18).

4. El mito del puente: la lección de BRIDGE

El ensayo **BRIDGE** (1.884 pacientes con fibrilación auricular que interrumpían warfarina) comparó **puente** con heparina de bajo peso molecular frente a **no puente**. No hacer puente fue **no inferior** para tromboembolismo arterial (0,4 % vs 0,3 %) y **redujo la hemorragia mayor** (1,3 % vs 3,2 %; RR 0,41) [1]. Conclusión práctica: en la mayoría de los pacientes con FA, **el puente sistemático añade sangrado sin proteger de la trombosis**; se reserva para casos de riesgo trombótico muy alto seleccionados.

> *CAMBIO DE CONDUCTA*
>
> BRIDGE invirtió una práctica arraigada: el «puente para todos» con heparina en FA es **perjudicial** en la mayoría. El puente queda para indicaciones de muy alto riesgo trombótico, valoradas individualmente [1].

5. Reanudación postoperatoria

La reanudación debe equilibrar la **hemostasia quirúrgica lograda** con el riesgo trombótico: se reinician los antitrombóticos cuando el riesgo de sangrado postoperatorio es aceptable, de forma escalonada y según el procedimiento. La **comunicación entre equipos** (anestesia, cirugía, cardiología/hematología) y la adhesión al protocolo local son esenciales para no dejar ventanas de riesgo [2].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el manejo de antitrombóticos perioperatorios es un balance individualizado entre trombosis y sangrado que depende del fármaco, del paciente y del procedimiento; muchos procedimientos de bajo riesgo no exigen suspender, y el **puente sistemático** con heparina en FA es perjudicial salvo en alto riesgo trombótico (BRIDGE).

Conecta con **PBM-15** (cribado del riesgo hemorrágico), **PBM-18** (reversión: CCP, agentes específicos) y con **PBM-13** (hemorragia grave bajo antitrombóticos). Resumen operativo en **P-QR-05**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Decide fármaco a fármaco según riesgo trombótico y hemorrágico —mantén la aspirina cuando puedas, suspende los ACOD según vida media y función renal, y evita el puente sistemático en FA—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **GUÍA** apoyado en BRIDGE [1], la guía ESAIC [2] y la guía EACTS/EACTAIC 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras de BRIDGE (tromboembolismo 0,4 vs 0,3 %; hemorragia mayor 1,3 vs 3,2 %, RR 0,41) [1] proceden de la fuente. Los tiempos exactos de suspensión por fármaco deben tomarse de los protocolos locales y la ficha técnica vigentes; aquí se da el marco de decisión, no dosis-día concretas.

8. Referencias

1. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, Becker RC, Caprini JA, Dunn AS, et al. Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation. *N Engl J Med* 2015;373(9):823–833. doi:10.1056/NEJMoa1501035 · PMID 26095867.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-16 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*